Processo nº **0084654-43.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): H. G. G. M. F.

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc...

H. G. G. M. F., menor impúbere, neste ato representado pelo seu genitor, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Requereu tramitação em segredo de justiça.

Consta na inicial que o genitor do autor é titular do plano de saúde ofertado pela ré há quase 15 anos, com a carteirinha sob o nº 0 034 7912 3058 6110 5, conforme ID. 177992383, mantendo a regularidade nos pagamentos (ID. 177992384).

Alega ainda que, o autor, atualmente com quatro anos de idade, nasceu prematuramente, com 28 semanas de gestação, e enfrentou sérias complicações médicas nos primeiros 99 dias de vida, o que impactou significativamente seu crescimento. Ao longo dos anos, foi diagnosticado com Baixa Estatura Idiopática, e o tratamento recomendado é a administração contínua de Somatropina (Hormônio do Crescimento). Sustenta que o tratamento é urgente e essencial para evitar comprometimentos adicionais no crescimento e no desenvolvimento da criança.

Apesar da prescrição médica (ID. 177992388), a Ré negou o pedido administrativo da cobertura do tratamento, conforme comprovado no ID. 177992395, alegando que a medicação não está inclusa no plano, o que gerou grande preocupação e dificuldades para a família, que enfrenta desafios financeiros. Argumenta que a negativa da cobertura pode resultar em graves consequências para a saúde e o desenvolvimento da criança.

Em razão do exposto, requer que seja concedida a tutela provisória para garantir a cobertura do tratamento, qual seja, fornecimento da Somatropina – dose 0.75mg/dia, pelo plano de saúde, dada a urgência e a importância da medicação para o bem-estar e desenvolvimento do Autor.

Proferido despacho determinando emenda à Inicial, a parte autora retificou o valor da causa. ID. 178822417.

Oportunizado o contraditório, a parte ré, em sede de contestação, preliminarmente requer o chamamento do Estado do processo. No mérito, alega que o contrato firmado entre as partes prevê a exclusão do fornecimento de medicação no âmbito domiciliar, conforme art. 31, alínea "f", e que consta no rol da ANS apenas os exames necessários para o diagnóstico de patologias ligadas ao hormônio do crescimento, não sendo de cobertura obrigatória o medicamento de uso domiciliar.

Ainda, a empresa ré defende a regularidade do seu proceder, amparada nos arts. 10, VI da Lei nº 9656/98, reforçando que não há cobertura legal / contratual para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, desde que não quimioterápicos (antineoplásicos).

Além disso, a ré alega a inexistência de dano moral, uma vez que sua conduta se baseou em preceitos legais e técnicos regulatórios, não havendo prática de ato ilícito eis que sua atuação é limitada pelas condições contratuais, legais e pelas diretrizes da ANS, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Assim vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar, **decido.**

Preliminarmente, analisando o pedido de reconsideração quanto à tramitação sob segredo de justiça, vislumbro que assiste razão ao requerente. Existe evidente conflito entre o interesse público quanto à transparência dos atos processuais e o direito à intimidade do autor / paciente quanto às suas informações de saúde. Portanto, tendo em vista o princípio de direito público de prevalência dos interesses dos menores, que tamém gozam de prioridade absoluta, defiro o pedido e determino a retificação do cadastro do feito.

Trata-se de Procedimento Comum em que o demandante pleiteia provimento jurisdicional que determine à parte ré a obrigação de fornecer o medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de injustificada recusa, o que caracteriza má prestação do serviço.

O feito comporta julgamento antecipado, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, além do que está suficientemente instruído com prova documental.

Não há que se falar em chamamento do Estado ao processo, eis que em se tratando de relação de consumo não há lugar para a denunciação da lide. A relação do autor para com o réu é absolutamente distinta da obrigatoriedade do poder público prestar a assistência médica e universal pelo SUS, aos que dele necessitem.

Destaco o que consta do laudo médico que instrui a inicial: "*A diagnóstico de Baixa Estatura – CID E 34.3, tendo como causa o fato de ter nascido pequeno para idade gestacional (PIG) – CID P05.1.*", o que ensejou a prescrição nos seguintes termos: *"O tratamento com o GH deve ser de uso contínuo, por tempo indeterminado. Geralmente a medicação somente é suspensa após o término do crescimento do paciente. A dose diária atual é de 0,75 mg/dia, porém esta dose sofrerá aumento ao longo do tratamento de acordo com o peso do paciente e os resultados dos exames laboratoriais. O número de ampolas mensais também irá aumentar ao longo do tratamento de acordo com a prescrição médica.".*

Não há dúvida quanto à existência da contratação e a negativa de cobertura, bem como ser adequada a medicação prescrita para tratar o quadro do autor.

Por outro lado, é importante consignar queo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela não obrigatoriedade das operadoras de saúde fornecerem medicação para uso domiciliar, exceto os neoplásicos haja vista expressa exclusão prevista no art. 10, VI, da lei nº 9656/98, consoante a seguir se vê:

"é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

No mesmo sentido, envolvendo a mesma medicação do caso sub judice, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2143661 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2506712258), Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação 21/05/2024; REsp 2059238, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 16/08/2024.

Impende transcrever a Ementa do Acórdão recente do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0002278-86.2023.8.17.9000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MELINA MARIA SALVINO DA SILVA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. REVOGADA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ***O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui da cobertura assistencial mínima prestada pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar.*** *Entendimento seguido pela ANS na Resolução Normativa nº 465/2021 e pelo Parecer Técnico nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021. Prejudicada a probabilidade do direito alegado.* ***2. Ausência de risco iminente à vida ou à saúde da paciente, afastando a urgência no provimento jurisdicional.*** *3. Recurso provido. Decisão unânime. Relator: Juiz Silvio Romero Beltrão"*

Nesse contexto, havendo **expressa previsão legal** que limita a obrigação da operadora de saúde no que diz respeito a fornecer medicação para uso domiciliar, consoante ressaltado no Acórdão supra, entende-se que a negativa encontra respaldo legal e está alinhada com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

É de se ressaltar que subsiste a obrigatoriedade do poder público prestar a necessária assistência à saúde da autora, conforme prescrevem as normas que regem o sistema único de saúde, o que, efetivamente, é incontroverso nos Tribunais pátrios.

As relações contratuais são regidas pelos princípios da boa-fé e força obrigatória, de modo que a intervenção judicial se restringe a impedir práticas ilegais e abusivas, o que não é o caso, sobretudo porque a recusa da operadora está amparada em texto expresso de lei, cuja interpretação somente pode ser relativizada nos casos em que houver risco de vida do paciente.

Ressalto posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo Interno em ED para hipótese semelhante, com a posição de ambas as suas Turmas ao caso:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. **TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.** JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. **2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.** 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, **por se tratar de equipamento de uso domiciliar**. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987778 SC 2022/0055671-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)" (grifos para destacar).

Mais:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. **PLANO DE SAÚDE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIRITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR.** RECURSO ESPECIAL PROVIDO." ((STJ - REsp: 2026198, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: 06/03/2023)" (grifos para destacar) .

"AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. **MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.** PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e

responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)" (grifos para destacar)

Incorporo ainda a estas razões de decidir os seguintes julgados, oriundos do TJPE:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Nos casos de urgência e emergência, em que o risco à vida se revele presente, admite-se interpretação extensiva do art. 10, VI, da lei 9.656/98 – que exclui da cobertura assistencial mínima o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar - para abranger o medicamento ministrado por orientação do médico assistente fora do regime de internação hospitalar, levando-se em conta a natureza do contrato de plano de saúde e a sua finalidade precípua de proteção à vida e à saúde do contratante. 2. Hipótese em que o tratamento medicamentoso pleiteado não se apresenta como terapia fundamental para a vida do paciente, mormente porque o laudo do médico assistente justifica a urgência do início do tratamento com o hormônio do crescimento tão somente no fato de a menor ficar com "altura final muito abaixo do padrão populacional feminino e genético". 3. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 0000272-59.2020.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00002725920208172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)).

"PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AFASTAR JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA E PRELIMINAR DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS REJEITADA. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENA. ESQUIZOFRENIA CRONICA. NEGATIVA. DOMICILIAR (NENHUMA HIPOTESE DO ARTIGO art. 10,VI, e 12 da Lei nº 9.656/1998. FÁRMACO QUE NÃO SE RELACIONA A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO, NEM DE USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. EXCLUSÃO ANS. ROL TAXATIVO. RECUSO DA RÉ PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório. Precedentes STJ. 2. In casu, EMBORA comprovada a necessidade de a paciente utilizar o medicamento solicitado como única terapia disponível, o Plano de Saúde não possui o dever de custear o medicamento de uso domiciliar (Invega Sustenna), pois extrapolaria os limites contratuais e legais, 3. Dado o provimento do recurso, inverte-se a sucumbência e fixa-se honorários advocatícios em R$ 500,00. 4. Recurso provido. (TJ-PE - AC: 00702011920198172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))" (grifos para destacar)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MONITOR E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ÍNDICES GLICÊMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE

CUSTEIO PELA SEGURADORA. TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O cerne da demanda consiste em averiguar o dever da Agravada em custear o tratamento perseguido nos autos - monitor e sensor contínuo de glicemia (FREESTYLE LIBRE). - Conforme estabelecido na Lei nº 9.656/98 e precedentes do c. STJ, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados (arts. 10, VI e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98). - Portanto, encontram-se excluídos da cobertura pelos planos de saúde aquelas medicações/insumos adquiridos facilmente em farmácias e cuja aplicação (uso) pode se dar no âmbito domiciliar (Precedentes c. STJ). - Do mesmo modo, diante da desnecessidade de intervenção médico-cirúrgicas relacionadas ao fornecimento do aparelho, encontram-se excluídos da cobertura obrigatória pelas operadoras, nos termos do art. 10, VII, da Lei de regência. - Recurso desprovido. (TJ-PE - AI: 00166532920228179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)" (grifos para destacar)"

Nesse contexto, considerando que a recusa foi amparada em expressa disposição legal, não há prática de ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar, razão pela qual o pedido inicial não há como ser acolhido.
Em que pese o art. 14 do CDC prever a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço frente ao consumidor, tal somente subsiste quando demonstrada a prática de ato ilícito, o que não ocorreu.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** e **JULGO IMPROCEDENTES** pedidos formulados na inicial, o que faço com fundamento nos dispositivos legais acima mencionados e declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

À Diretoria Cível para retificar o valor da causa, conforme valor indicado na petição ID. 178822417.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos estipulados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade concedida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões e encaminhem-se os autos ao E. TJPE, observadas as formalidades legais, independentemente de novo despacho.

Recife-PE, 9 de setembro de 2024.

ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
09/09/2024 16:10:53
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 181601694

24090916105361900000177177272

IMPRIMIR GERAR PDF